

Ministerio de Salud
Personas que atendemos Personas

Perú, 2005

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ESCUELAS SALUDABLES

Gobierno del Perú
Trabajo de peruanos

Ministerio de Salud
Personas que atendemos Personas

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
MINISTERIO DE SALUD
PERÚ - 2005

Catalogación hecha por el Centro de Documentación OPS/ OMS en el Perú

Programa de Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas/Ministerio de Salud. Dirección General de Promoción de la Salud. Programa de Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas. -- Lima: Dirección General de Promoción de la Salud, 2005. 48 p.

PROMOCIÓN DE LA SALUD / SALUD ESCOLAR / EDUCACIÓN EN SALUD / ACREDITACIÓN / PERÚ

Hecho el Depósito Legal N° 2005-2898
ISBN 9972-2588-1-5

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 11 de ABRIL del 2005

Visto, el Expediente Nº 092112-04, que contiene la propuesta de la Dirección General de Promoción de la Salud, con relación al PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS;

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Salud es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del sistema, teniendo entre sus competencias la articulación de recursos, actores públicos y privados intra e intersectoriales, que puedan contribuir al logro de los objetivos de las políticas públicas de salud;

Que el artículo 8° del Reglamento de Ley del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N°013-2002-SA, señala que el proceso de promoción de salud tiene como objetivo funcional lograr que las personas adquieran capacidades y desarrollen actitudes, para su desarrollo físico, mental y social;

Que para el logro de sus objetivos, el Ministerio de Salud suscribió el 05 de agosto de 2002, el Convenio Marco de Cooperación Técnica con el Ministerio de Educación que tiene como finalidad, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del educando en su entorno familiar y comunitario, mediante la promoción de la salud y el óptimo desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales, sociales y emocionales, ampliando la cobertura de atención en educación y salud en zonas rurales dispersas y urbano marginales de alta vulnerabilidad, fomentando el uso del espacio escolar como lugar estratégico para promover una cultura de salud;

Que en concordancia con lo anterior, es necesario implementar el Programa de Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas, en el contexto del Convenio de Cooperación Técnica celebrado entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, que impulse la promoción de la salud, de acuerdo a los Lineamientos de Política Sectorial 2002– 2012;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Promoción de la Salud y a la visación de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

Con la visación del Viceministro de Salud; y,

De conformidad con lo establecido en el inciso l) del artículo 8° de la Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el **PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,** la misma que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- La implementación, ejecución y evaluación del **PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS** serán cumplidas a través de las Direcciones de Promoción de la Salud de las Direcciones Regionales de Salud, o las que hagan sus veces a nivel nacional.

Artículo 3°.- Encargar a la Oficina General de Comunicaciones la publicación del presente Programa en la página web del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese

Dra. Pilar MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Salud
Personas que atendemos Personas

Señora Doctora
PILAR MAZZETTI SOLER
MINISTRA DE SALUD

Señor Doctor
JOSÉ CARLOS DEL CARMEN SARA
VICE MINISTRO DE SALUD

Señor Doctor
RICARDO BUSTAMANTE QUIROZ
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Señora Licenciada
MERCEDES ARÉVALO GUZMÁN
DIRECTORA EJECUTIVA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

EQUIPO DE TRABAJO

Mg. Raúl Choque Larrauri

Dr. Richar Ruiz Moreno

Lic. Lilian Uchima Heshiki

Lic. Inés Vaccari Vega-Centeno

Mg. María Teresa Arana Zegarra

Ps. Nancy Fuk Reynoso

Este documento fue validado por los equipos técnicos de las 34 Direcciones Regionales de Salud y Direcciones de Salud de todo el país en cuatro talleres macroregionales realizados en el mes de octubre del 2004 en las sedes de Junín, Lambayeque, Lima y Arequipa.

ÍNDICE

Contenido	Página
Presentación	11
Introducción	12
CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL	13
1.1 Antecedentes internacionales	15
1.2 Antecedentes nacionales	16
1.3 Situación del escolar en el Perú	18
CAPÍTULO 2: ASPECTOS GENERALES	21
2.1 Base Legal	23
2.2 Marco conceptual de la Promoción de la Salud	23
2.3 Modelo de Atención Integral de Salud	23
2.4 Modelo de Abordaje de la Promoción de la Salud en Perú	24
2.5 Enfoques	25
2.6 Estrategias	26
2.7 Conceptos básicos	26
CAPÍTULO 3: ASPECTOS ESPECÍFICOS	29
3.1 Programa de Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas	31
3.2 Objetivos del Programa	31
3.3 Líneas de acción	31
CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN	35
4.1 Proceso de intervención	37
4.2 Metodologías educativas	38
4.3 Acreditación	40
4.4 Monitoreo y evaluación	41
Anexos	43
Anexo N° 01	45
Anexo N° 02	46
Anexo N° 03	47
Bibliografía	48

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Salud tiene como primer Lineamiento de Política Sectorial la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, protegiendo la dignidad de las personas y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país, con la finalidad de desarrollar una cultura de salud a través del fomento de entornos y estilos de vida saludables y la reorientación de los servicios de salud.

La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud reconoce que la salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana: en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo, proporcionando a su vez los medios necesarios para mejorar y ejercer un mejor control sobre la salud poblacional, garantizando entornos saludables, entre ellos el educativo, que permita un adecuado desarrollo físico, psicológico, emocional y social de los estudiantes.

El Ministerio de Salud tiene la misión de implementar el proceso de promoción de la salud a nivel nacional en coordinación con el sector Educación, los Gobiernos Locales, las organizaciones privadas y la familia como unidad básica, con lo cual se garantizarán estándares adecuados de salud para la comunidad.

La institución educativa es un espacio estratégico de formación y desarrollo, pues es allí donde los alumnos elaboran conocimientos, fortalecen hábitos e internalizan los valores que los conducirán hacia una vida plena.

En ese sentido, el Ministerio de Salud ha desarrollado el Programa de Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas, que se concibe como una estrategia para fortalecer el desarrollo de la promoción de la salud, partiendo de la conceptualización de que la Institución Educativa apoya el desarrollo integral de los niños y adolescentes del sistema educativo, y por ende de aspectos relacionados a la salud, siendo el accionar del sector salud básicamente de asistencia técnica. Para su operacionalización las acciones de promoción de la salud deben estar contempladas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y son los Consejos Educativos Institucionales (CONEI), los que participan activamente en su implementación, monitoreo, evaluación, vigilancia y concertación con la comunidad local.

La elaboración de esta propuesta permite fortalecer el accionar del Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Educación, en aras de mejorar la calidad de vida de la población, reconociendo en la educación y la salud los pilares fundamentales de desarrollo de nuestro país.

Dr. Ricardo Bustamante Quiroz
Director General de Promoción de la Salud

INTRODUCCIÓN

El Programa de Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas tiene como objetivo general contribuir al desarrollo humano integral de los estudiantes y de la comunidad educativa a través del fortalecimiento de acciones de promoción de la salud en las Instituciones Educativas.

Las líneas de acción propuestas son promoción de comportamientos saludables, desarrollo de entornos saludables, trabajo intersectorial e implementación de políticas que promuevan salud, las mismas que se incorporarán en el Proyecto Educativo Institucional de las Instituciones Educativas, para lo cual el sector salud brindará la capacitación y el apoyo técnico.

En el año 2004 se trabajó en 1,644 instituciones educativas de educación primaria y 736 instituciones educativas de educación secundaria a nivel nacional. Se beneficiaron 568,797 estudiantes, con la participación de 14,897 profesores capacitados de educación primaria y 5,874 profesores de educación secundaria. Los temas desarrollados fueron higiene, prevención del dengue y otros de acuerdo a cada realidad local, promoviendo de esta manera, un trabajo descentralizado y articulado entre los diferentes actores de la comunidad.

Para el año 2005, se tiene planificado trabajar en 3,120 Instituciones Educativas a nivel nacional, que incluyen las Instituciones Educativas que están inmersas en el Programa de Emergencia Educativa. Los ejes temáticos que se desarrollarán son habilidades para la vida, salud sexual y reproductiva y alimentación y nutrición.

Cabe destacar que este Programa responde al Convenio entre el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación que suscribieron el año 2002, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del estudiante y el óptimo desarrollo de sus capacidades, fomentando el uso del espacio escolar como lugar estratégico para promover una cultura de la salud y el bienestar.

Se espera que esta propuesta contribuya al desarrollo de los niños y adolescentes del país, desde el espacio privilegiado de la Institución Educativa, construyendo de esta manera una cultura de la salud.

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

1.1 Antecedentes Internacionales

Existe una trayectoria de varias décadas de programas de salud escolar en el mundo, que a sus inicios se caracterizaron por una fuerte tendencia a la concentración de esfuerzos en el mejoramiento de las condiciones de higiene y saneamiento ambiental, la prevención de enfermedades, el tratamiento de enfermedades específicas y exámenes médicos. Aunque a comienzos del Nuevo Milenio estas tendencias no han desaparecido por completo de los programas de salud escolar en el mundo, es indiscutible que se han logrado avances considerables en todos los países en el camino hacia un enfoque integral de la salud en las escuelas, a través de la incorporación de acciones de promoción de la salud en este importante escenario.

La Red de Escuelas Promotoras de Salud surgió a partir de las recomendaciones de la Conferencia Europea sobre Promoción y Educación para la Salud (Estrasburgo, 1990), donde expertos en salud y educación, funcionarios e investigadores consideraron que el fortalecimiento de la promoción y educación para la salud en las escuelas requería de diversas actividades y mecanismos para promover el intercambio de experiencias e información.

En los países europeos, este esfuerzo común recibió el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Consejo de Ministros de la Comunidad Europea. El apoyo político favoreció la introducción de la educación para la salud en las escuelas. En 1993 se creó oficialmente la Red Europea de Escuelas Promotoras de la Salud. Esta Red promueve el desarrollo de las escuelas saludables, facilitando la adopción por toda la comunidad educativa, de modos de vida sanos en un ambiente favorable a la salud, así como instaurando un entorno físico y psicosocial saludable y seguro. La primera reunión de la Red Europea la realizaron en Grecia en 1997 y en el acta constitutiva se declaró que "Todos los niños y jóvenes de Europa tienen el derecho y han de tener la posibilidad de estudiar en una escuela promotora de la salud".

En el caso de la Región de las Americas, en Costa Rica en 1993, la Organización Panamericana de Salud-Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS), lleva a cabo una reunión de consulta para analizar la situación de la educación para la salud, actualizar sus lineamientos y proponer una perspectiva regional. A partir de esta reunión se comenzó a elaborar el documento Educación para la Salud en el ámbito Escolar: una Perspectiva Integral, publicado en 1995. Este documento contiene las recomendaciones a los estados miembros, para la puesta en marcha de la iniciativa de escuelas promotoras de salud.

A partir de esa reunión en el año 1995, la Oficina Regional de la Salud OPS - OMS, realizo el lanzamiento de la iniciativa de la Escuelas Promotoras de la Salud en la Región del las Américas, con la finalidad de promover salud en los centros de enseñanza, promoviendo para ello la constitución de la Red Latinoamericana de Escuelas Promotoras de la Salud (RLEPS).

La I Reunión de la Red Latinoamericana de Escuelas Promotoras de la Salud se realizó en 1996 en San José de Costa Rica, con el respaldo y compromiso de 14 países. En esta reunión se constituyó oficialmente la Red, estableciéndose los objetivos y planes de acción a nivel de la región y de cada país.

La II Reunión de la Red Latinoamericana de Escuelas Promotoras de la Salud se realizó en 1998 en México, donde se lograron acuerdos importantes sobre la organización y desarrollo de acciones de promoción de la salud en las escuelas de la región.

La III Reunión de la Red Latinoamericana de Escuelas Promotoras de la Salud se realizó del 10 al 13 de setiembre de 2002, en la ciudad de Quito, Ecuador. En esta reunión se logró apoyar la organización y el desarrollo de las Escuelas Promotoras de la Salud (EPS) y las redes en cada país de la región, así como facilitar el intercambio de sus experiencias apoyando la apertura y constitución de vías de comunicación multidireccional, que se entrelacen y sean convergentes en puntos de interés para el mejoramiento de la educación y de la salud en ámbito escolar.

La IV Reunión de la Red Latinoamericana de Escuelas Promotoras de la Salud, se realizó del 11 al 16 de julio del 2004, en la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Asistieron a este evento delegado/as oficiales de salud y educación de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, así como participantes de Aruba, Australia, Canadá, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Italia y Trinidad y Tobago. En esta reunión se logró fortalecer la estructura, gestión y metas organizacionales de la RLEPS, se propició el debate crítico sobre aspectos relacionados con las posibilidades y condiciones de salud y bienestar, educación y desarrollo integral de la población en edad escolar, en el contexto político, económico, sociocultural y sanitario específico de los países de América Latina y el Caribe en el presente siglo. En esta importante reunión el Perú fue designado para asumir la Secretaría Técnica de la Red de Escuelas Promotoras de la Salud de la Comunidad Andina.

En el I Encuentro Nacional de Promoción de la Salud en el Perú en noviembre del 2004 se llevó a cabo la 1ra reunión de la Red Latinoamericana de Escuelas Promotoras de Salud RLEPS-Sub Región Andina, donde participaron Ecuador, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y se acordó trabajar de manera conjunta para el desarrollo de la promoción de la salud en el ámbito escolar de la Sub Región Andina.

1.2 Antecedentes Nacionales

En el país se tiene un desarrollo importante de las escuelas saludables tanto desde el sector público como de las instituciones cooperantes y organismos no gubernamentales de desarrollo.

Una de las primeras experiencias la desarrolló la Asociación Kallpa en 1988 en el Cono Sur de Lima, extendiéndose luego al Cusco, Ayacucho e Iquitos. De igual forma la institución Plan Internacional desarrolla el componente de Higiene en los Centros Educativos en el nivel primario, de las regiones de Lima, Piura y Cusco.

Otra experiencia es "Escuelas Amigas", impulsada por UNICEF a través del Ministerio de Educación en zonas rurales y urbano-marginales. Se trabaja la democratización del aula, el autogobierno de los alumnos, la mejora de la calidad educativa y una educación integral que involucre la salud.

En los años 2001-2002 el Sub Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, consideró en la Línea de Prevención de Violencia implementar las actividades de habilidades sociales para la prevención de conductas violentas en el adolescente, para ello se programó el desarrollo de estas actividades en las 34 DISAS y 16 talleres en los Centros Educativos. Se utilizó el Manual de Habilidades Sociales para la Prevención de Conductas Violentas en el Adolescente elaborado y validado por el IESM Honorio Delgado Hideyo Noguchi, con el objetivo de desarrollar habilidades sociales en los adolescentes con riesgo a presentar conductas violentas, dicho documento tenía como contenido: Módulos de Autoestima, Comunicación, Asertividad y Toma de Decisiones.

El Ministerio de Salud desarrolló diversas acciones educativas en los centros educativos a través del Programa de Salud del Escolar y Adolescente, habiéndose suscrito un convenio de cooperación técnica entre el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación el año 1993.

En la actualidad se vienen desarrollando una serie de experiencias de Escuelas Promotoras de la Salud por diversas instituciones como son Catalyst y Pathfinder Internacional, entre otras.

En el año 2003 se inició el Programa de Escuelas Saludables en el Ministerio de Salud, en el marco del Convenio de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Este Programa actualmente se desarrolla en 3,250 Instituciones Educativas del país, beneficiando aproximadamente a 500,000 estudiantes.

A fin de oficializar el trabajo en las escuelas, el 28 de Octubre del 2004 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano", la aprobación vía Resolución Ministerial de la Directiva del Indicador del Programa de Promoción de la Salud en los Centros Educativos, que norma a nivel nacional el desarrollo de las Escuelas Saludables, bajo la responsabilidad de las Direcciones Regionales de Salud del país.

En Noviembre del 2004 se realizó el I Encuentro Nacional de Promoción de la Salud donde se conformó la Red Nacional de Escuelas Promotoras de la Salud constituyéndose en un importante hito en el país para el desarrollo del Programa. Asimismo en el marco del Encuentro se realizó la 2da. Reunión de las Escuelas Promotoras de Salud. Como producto del Encuentro se emitió la Declaración de Lima que entre uno de sus acuerdos promueve el desarrollo de las escuelas saludables en el país.

Convenio Marco entre el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación

Un paso significativo para el trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación lo constituye el convenio de cooperación técnica MINSA-MED firmado el 05 de Agosto del 2002.

Mediante este Convenio MINSA-MED, ambos Ministerios expresaron su voluntad y acuerdo de un trabajo conjunto para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del educando en su entorno familiar y comunitario, mediante la promoción de la salud y el óptimo desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales, sociales y emocionales, ampliando la cobertura de atención en educación y salud en zonas rurales dispersas y urbano marginales de alta vulnerabilidad, fomentando de esta manera el uso del espacio escolar como lugar estratégico para promover una cultura de la salud.

Los objetivos específicos del convenio son:

Con relación a los beneficiarios directos: Brindar atención a los educandos en aspectos preventivo promocionales de su salud, incluyendo el adecuado control del crecimiento y desarrollo de la niñez, mediante una nutrición preventiva, a través del cuidado y tratamiento oportuno de las personas menores de 18 años, con énfasis en los menores de 5 años, así como el fortalecimiento de las capacidades psicosociales que les permitan crecer saludablemente en contextos de riesgo; incrementar la cobertura y el acceso a la educación formal y no formal, así como la atención en salud, con especial cuidado del crecimiento y desarrollo de los menores de 2 años en las zonas rurales dispersas y urbano marginales de extrema pobreza; propiciar la detección temprana de problemas de aprendizaje y de salud en los educandos y coordinar, articular y complementar servicios de salud y educación para

los educandos, alrededor de los programas educativos y de salud que se ofrecen a los niños de las zonas rurales y urbano marginales de extrema pobreza.

Con relación a la comunidad educativa: orientar a la comunidad sobre la importancia de la educación temprana en menores de 6 años, así como el mejoramiento de las prácticas de crianza familiar que guarden relación con el respeto de los valores y tradiciones nacionales, orientando esfuerzos hacia la población de extrema pobreza; generar en los actores de la comunidad educativa, conocimientos y habilidades para el desarrollo de prácticas saludables, tanto individuales como colectivas; promover en la comunidad educativa, la difusión de contenidos en alimentación, nutrición, higiene y el uso adecuado de medicamentos y medicina tradicional y el peligro de utilización irracional de los mismos, tanto a nivel grupal como a través de medios de difusión masiva; fomentar prácticas saludables que relacionen a los educandos con su ambiente familiar, social y ecológico; promover una cultura de alfabetismo que a su vez integre la promoción y prevención de todo tipo de enfermedades, orientando los esfuerzos hacia una cultura saludable; evaluar conjuntamente el impacto de las acciones que se desprendan de la ejecución del presente Convenio.

Para la implementación del Convenio el Ministerio de Educación está representado por la Oficina de Tutoría y Prevención Integral y el Ministerio de Salud por la Dirección General de Promoción de la Salud.

1.3 Situación Actual del Escolar en el Perú

Uno de los objetivos estratégicos del sistema educativo es formar niños y adolecentes como ciudadanos capaces de construir la democracia, el bienestar y el desarrollo nacional, armonizando este proyecto colectivo con su propio proyecto personal de vida.

El sistema educativo en nuestro país atiende el 82,4% de los niños de 5 años; el 96,9% de los niños entre los 6 y los 11 años; y el 85,9% de los adolescentes entre los 12 y 16 años. Reflejando avances en su nivel de cobertura.

En los cuadros 1, 2 y 3 se especifica la población escolar, el número de Instituciones Educativas y el número de profesores del Sistema Educativo Peruano:

Cuadro N° 01

Perú: Población Escolar

NIVELES Y MODALIDADES	ESTATAL	NO ESTATAL	TOTAL
Educación inicial	901,835	176,443	1´078,277
Educación primaria	3´682,149	594,576	4´276,725
Educación secundaria	2´166,665	467,290	2´633,956
	6´750,649	1´238,309	7´988,958

Fuente: Ministerio de Educación, Lima Marzo 2003.

Perú: Instituciones Educativas

NIVELES Y MODALIDADES	ESTATAL	NO ESTATAL	TOTAL
Educación inicial	25,133	5,925	31,058
Educación primaria	28,027	5,971	33,928
Educación secundaria	6,294	3,191	9,485
	60,084	15,087	74,471

Fuente: Ministerio de Educación, Lima Marzo 2003.

Perú: Profesores

NIVELES Y MODALIDADES	ESTATAL	NO ESTATAL	TOTAL
Educación inicial	26,713	16,327	43,040
Educación primaria	139,864	43,036	182,900
Educación secundaria	111,593	45,082	156,676
	278,170	104,445	382,616

Fuente: Ministerio de Educación, Lima Marzo 2003.

En 1996, la tasa de mortalidad infantil fue de 43 por mil nacidos vivos, según la ENDES 2000, el promedio nacional de mortalidad infantil se redujo a 33 por mil nacidos vivos. Sin embargo, en sectores de menores ingresos, la mortalidad infantil aumentó, lo que significa que el promedio nacional mejoró porque la mortalidad infantil descendió en sectores de mayores ingresos. Esto muestra el incremento de la desigualdad social y sus consecuencias en la salud.

Según la ENDES 2000, la prevalencia de la desnutrición crónica infantil se ha mantenido casi en el promedio de 1996: 25.4% versus 25.8% respectivamente. Esto demuestra la crítica situación de la salud infantil.

Cada vez es mayor el número de niños y adolescentes que trabajan paralelamente a sus estudios, los cuales son más vulnerables a presentar problemas de salud. El Ministerio de Educación a través de la Oficina de Tutoría y Prevención Integral (OTUPI), ejecutan programas de atención a fin de asegurar la permanencia sostenida del educando en el sistema educativo, evitando el ausentismo y deserción por razones de trabajo.

Los adolescentes exhiben problemas de accidentes de tránsito, participación en acciones violentas (riñas, pandillaje, etc), inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, enfermedades de transmisión sexual y SIDA, violencia intrafamiliar, etc.

Según la Dirección de Participación Ciudadana de la Policía Nacional del Perú, existen 400 pandillas entre Lima y Callao a febrero del 2000, con aproximadamente 12 mil 950 personas, entre adolescentes y adultos. El 88% tiene menos de 24 años.

El 49% de los niños son maltratados por sus padres, siendo considerada esta práctica por los propios niños como un método natural de disciplina y educación.

La farmacodependencia es un problema de salud pública en el país. Los registros estadísticos ilustran que la población de mayor riesgo frente al consumo de drogas sigue siendo los adolescentes. El consumo y abuso de drogas legales como el alcohol y el tabaco son la puerta de inicio para el consumo de otras drogas ilegales.

Los adolescentes necesitan una educación integral, que contribuya a su formación como personas, al desarrollo de sus capacidades relacionadas con los valores de la convivencia, a conocer y manejar sus emociones y conflictos, entender a los demás, fijarse propósitos significativos en su vida, aprender a comprometerse, a ser solidarios, etc. Necesitan desarrollar habilidades que les facilite enfrentarse con éxito a las exigencias y desafíos de la vida cotidiana en su propia familia, en la escuela y la comunidad.

Los datos y cifras estadísticas presentadas revelan la situación de educación y salud de los niños y adolescentes del país, y la necesidad de intervenciones inmediatas y sostenibles desde dos sectores: Salud y Educación, pilares del desarrollo integral de la persona.

CAPÍTULO 2

ASPECTOS GENERALES

2.1 Base Legal

1. Ley General de Salud N° 26842.

2. Decreto Supremo N° 014-2002-SA Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.

3. Ley del Ministerio de Salud N° 27657.

4. Resolución Ministerial N° 101-2003-SA/DM, que aprueba la implementación de la estrategia nacional denominada "Perú-Vida 2012".

5. Lineamientos de Política Sectorial para el periodo 2002-2012 y los Principios Fundamentales para el Plan Estratégico Sectorial para el quinquenio agosto 2001-Julio 2006 - Ministerio de Salud.

6. Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud del año 2002.

2.2 Marco Conceptual de Promoción de la Salud

La Promoción de la Salud, en concordancia con la definición de la OMS es "el proceso que da a la población, los medios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y de mejorarla. Para alcanzar un estado completo de bienestar físico, social y mental, un individuo o un grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y cambiar o adecuar el medio ambiente".

En tal sentido, la Promoción de la Salud involucra a personas, familias y comunidades en un proceso de cambio orientado a modificar los condicionantes y determinantes de la salud: ingreso y posición social, redes de apoyo social, educación, empleo y condiciones de trabajo, entorno físico, características biológicas, dotación genética, hábitos personales, aptitudes de adaptación y servicios de salud.

Para la Promoción de la Salud el escenario escolar es fundamental pues es donde se desarrollan acciones de aprendizaje creadas para ampliar el conocimiento de los estudiantes en relación con la salud, desarrollando la comprensión y las habilidades personales para facilitar cambios de conducta que promuevan estilos de vida saludable.

2.3 El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS)

El Ministerio de Salud ha señalado, como uno de sus lineamientos fundamentales para el periodo 2002-2012, la implementación de un Modelo de Atención Integral (MAIS) basado en los principios de universalidad en el acceso, la equidad, la integralidad de la atención, la continuidad de los servicios, la calidad de la atención, la eficiencia, el respeto a los derechos de las personas, la promoción de la ciudadanía y la satisfacción de los usuarios. Este modelo supone, en términos generales, "priorizar y consolidar las acciones de atención integral con énfasis en la promoción y prevención, cuidando la salud, disminuyendo los riesgos y daños de las personas en especial de los niños, mujeres, adultos mayores y discapacitados."

El documento marco, aprobado con RM 729-2003 del 20 de junio del 2003, plantea que "El nuevo Modelo de Atención Integral en Salud" constituye el actual marco de referencia para la atención de salud en el país, basado en el desarrollo de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación, orientados a obtener una persona, familia y comunidad saludable.

En ese contexto, la Dirección General de Promoción de la Salud a través de la Dirección Ejecutiva de Educación para la Salud tiene entre sus funciones:

- Proponer políticas y participar en su implementación para contribuir al desarrollo de intervenciones educativas y de comunicación para la promoción de la salud, de aplicación en el ámbito nacional, regional y local.
- Conducir la elaboración, implementación y evaluación de contenidos, medios, materiales e instrumentos educativo comunicacionales, para las intervenciones en promoción de la salud, con énfasis en el fortalecimiento de valores y la construcción de la cultura de la salud.
- Coordinar con el Ministerio de Educación la incorporación en la currícula escolar de contenidos educativos para la promoción de la salud.
- Programar, formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos para desarrollar intervenciones de educación y comunicación para la salud.
- Desarrollar normas y procedimientos para intervenciones de educación y comunicación de promoción de la salud y vigilar su cumplimiento y participar en el desarrollo de alianzas estratégicas para el desarrollo y evaluación de intervenciones de educación y comunicación para la promoción de la salud.

Estas funciones permiten desarrollar la promoción de la salud en el ámbito educativo en concordancia con el MAIS.

2.4 Modelo de Abordaje de la Promoción de la Salud en el Perú

El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Promoción de la Salud desarrolla el Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud (Cuadro N° 04) el mismo que contiene las bases teórico referenciales en promoción de salud para orientar los esfuerzos a nivel de los establecimientos de salud y la sociedad civil en la implementación de iniciativas que contribuyan a crear una cultura de salud y mejorar la calidad de vida en las poblaciones.

El modelo considera enfoques y estrategias dirigidos a la población sujeto de intervención con la finalidad de lograr entornos saludables y desarrollar comportamientos saludables.

Buscando mejorar la calidad de vida de las poblaciones y siendo necesario complementar acciones dirigidas a la persona en sus diferentes etapas de vida en los establecimientos de salud, este modelo plantea abordar a la población en los diferentes escenarios como son: la vivienda, la institución educativa, municipios, centros laborales y la comunidad en general, entendiéndose como escenario al espacio geoterritorial y de dinámica social donde se desarrollan los procesos relacionados con las condiciones de vida y salud de las personas.

Las acciones a implementar en estos escenarios son abordados a través de ejes temáticos priorizados: alimentación y nutrición, higiene y ambiente, habilidades para la

vida, salud mental, buen trato y cultura de paz, salud sexual y reproductiva y seguridad vial y cultura de tránsito.

La manera de operativizar este modelo es a través de PROGRAMAS en promoción de la salud que son el conjunto de acciones integrales y sostenibles a nivel de los escenarios considerando además la población sujeto de intervención para alcanzar resultados que favorezcan condiciones de vida saludables en la población y su entorno. Los Programas que ha considerado la Dirección General de Promoción de la Salud son: Programa de Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas, Programa de Familia y Vivienda Saludables, Programa de Municipios y Comunidades Saludables y Programa de Centros Laborales Saludables.

Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud en el Perú

ENFOQUES TRANSVERSALES	ESTRATEGIAS	POBLACION SUJETO DE INTERVENCION		ESCENARIOS (entornos saludables)	EJES TEMATICOS (comportamientos saludables)
Equidad y derechos en salud	Abogacía y políticas públicas	Familia	Etapas de vida	Vivienda	Alimentación y nutrición Higiene y ambiente
Equidad de género	Comunicación y educación para la salud	Comunidad	Niño Adolescente Adulto Adulto mayor	Institución educativa Municipios	Actividad Física Salud sexual y reproductiva Habilidades para la vida Seguridad vial y cultura de tránsito
Inter culturalidad	Participación comunitaria y empoderamiento social			Centros laborales	Promoción de la salud mental, buen trato y cultura de paz

2.5 Enfoques Transversales

2.5.1 Equidad y derechos en Salud

Es un enfoque que fortalece aprendizajes de participación ciudadana en salud desde la Institución Educativa puesto que es un espacio donde niños y adolescentes descubren el sentido de lo público y donde aprenden y ejercen su ciudadanía. Este proceso garantiza que exista no sólo una información en derechos en salud sino un proceso que asegure que los niños y adolescentes ejerzan efectivamente sus derechos, incorporándolos como miembros con voz de su comunidad, con el derecho y deber de contribuir a formar una sociedad más equitativa.

5.2 Equidad de genero

Es un enfoque mediante el cual se procura minimizar las diferencias de oportunidades para la salud plena de hombres y mujeres integrantes de las Instituciones Educativas, mediante el desarrollo de acciones de aprendizaje diferenciados que respondan a las necesidades específicas de hombres y mujeres.

5.3 Interculturalidad

Es un enfoque que permite reconocer los diferentes modos de vivir, pensar y sentir de los miembros de las Instituciones Educativas en el contexto de las diferentes realidades locales y regionales de nuestro país, implementando acciones diferenciadas que respondan a necesidades según nuestro contexto cultural.

2.6 Estrategias

2.6.1 Abogacía y políticas públicas

La abogacía es una estrategia destinada a conseguir compromisos y apoyo de decisores políticos de los diferentes sectores sobre temas de importancia como son el fortalecimiento de acciones de promoción de la salud en las instituciones educativas. En el Programa se establece una coordinación permanente con el sector educación, a fin de promover políticas públicas orientadas a mejorar la salud de la comunidad educativa.

2.6.2 Comunicación y educación para la salud

La comunicación, la educación y la salud coinciden y se encuentran en la persona; por un lado la comunicación refuerza los mensajes que contribuyen a la construcción de comportamientos y estilos de vida saludables, a través de los medios; la educación propicia y facilita el desarrollo de sus capacidades personales y sociales para el desarrollo de las mismas y su ejercicio de la vida en sociedad. La educación para la salud constituye una estrategia de enseñanza-aprendizaje que propicia cambios favorables en la salud del que aprende, ayudándolo a construir conocimientos, saber aplicarlos; asimismo le facilita las herramientas para comprender, analizar, reflexionar, evaluar y desarrollar competencias y habilidades personales y sociales que permanezcan en el tiempo.

2.6.3 Participación comunitaria y empoderamiento social

La participación comunitaria incide en la consolidación de mecanismos de control y de corresponsabilidad y se enmarca en el reconocimiento de derechos y responsabilidades en el mantenimiento de su salud. En la comunidad educativa es fundamental la participación activa y consciente de la comunidad a fin de consolidar un entorno educativo saludable.

Conceptos básicos

Cultura de la salud

La salud se entiende como "El equilibrio armonioso de las áreas física, social y espiritual que le permite a la persona un desarrollo humano integral". Esta definición pone un marcado énfasis en rescatar la integralidad de la persona y la necesidad de reorientar los esfuerzos en el área de la salud hacia el despliegue máximo de su potencial de desarrollo. Las acciones en salud deben habilitar a las personas para alcanzar las mejores posibilidades de realización plena. Es por ello que la Promoción de la Salud busca la construcción de una

Cultura de la Salud, es decir, la incorporación personal y social de un sistema de conocimientos, costumbres y valores que perduren en el tiempo.

2.7.2 Educación para la salud

Entendemos la educación como un proceso sociocultural permanente por el cual las personas se van desarrollando para beneficio de sí mismas y de la sociedad, mediante una intervención activa e intencionada en los aprendizajes, que se logran por interacción en ámbitos de educación formal, no formal e informal. (Propuesta de diseño curricular básico. Ministerio de Educación, 2000)

Supone por tanto, el desarrollo de capacidades y habilidades sociales y personales necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la propia salud y crear las posibilidades para actuar en la comunidad, logrando cambios que favorezcan la salud colectiva.

"La Educación para la salud es toda actividad libremente elegida que participa en un aprendizaje de la salud o de la enfermedad, es decir, en un cambio relativamente permanente de las disposiciones o de las capacidades del sujeto. Una educación para la salud, eficaz puede así producir cambios a nivel de conocimientos, de la comprensión o de las maneras de pensar; puede influenciar o clarificar los valores, puede determinar cambios de actitudes y de creencias; puede facilitar la adquisición de competencias; incluso puede producir cambios de comportamientos o de modos de vivir" (TONES, 1994; 28)

La Educación para la Salud es un proceso de formación y compromiso, que involucra un cambio de actitudes de la persona, donde construye y hace suyos los valores, criterios y hábitos que la conducirán a la vivencia de los mismos en lo cotidiano, para la defensa y la promoción de la salud en la vida personal, familiar y de la comunidad.

2.7.3 Eje temático

Es el contenido técnico conceptual sobre un tema priorizado en Promoción de la Salud. Fundamenta y brinda los contenidos técnicos a los Programas de Promoción de la Salud según población sujeto de intervención. Los ejes temáticos priorizados son: higiene y ambiente, alimentación y nutrición, actividad física, salud sexual y reproductiva, habilidades para la vida, seguridad vial y cultura de tránsito, promoción de la salud mental, buen trato y cultura de paz.

CAPÍTULO 3

ASPECTOS ESPECÍFICOS

3.1 Programa de Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas

El Programa de Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas permite fortalecer el accionar de promoción de la salud, involucrando a los estudiantes, profesores, padres de familia y comunidad educativa, con el fin de incorporar y fortalecer comportamientos saludables.

El desarrollo de la Promoción de la Salud en el entorno educativo pretende hacer de las Instituciones Educativas un espacio lleno de vida, donde los niños y adolescentes crezcan sanos y felices, donde se compartan valores para la vida, se identifiquen principios, se adopten comportamientos saludables, donde los docentes refuercen su vocación profesional y donde los padres de familia encuentren un ambiente acogedor.

Se considera Institución Educativa Saludable a aquella que ha alcanzado estándares de mejoramiento en su entorno, y cuya comunidad educativa mantiene comportamientos saludables en su vida cotidiana.

3.2 Objetivos del Programa:

3.2.1 Objetivo general

Contribuir al desarrollo humano integral de los estudiantes y de la comunidad educativa mediante el fortalecimiento de acciones de promoción de la salud en las Instituciones Educativas.

3.2.2 Objetivos específicos

- Promover comportamientos saludables en los escolares de primaria y secundaria así como en los demás actores de la comunidad educativa en los ámbitos de aplicación del Programa.

- Fortalecer el trabajo intersectorial coordinado entre el Sector Educación y el Sector Salud. La Institución Educativa y el Centro de Salud.

- Promover en las Instituciones Educativas la incorporación de la promoción de la salud en el Proyecto Educativo Institucional.

3.3 Lineas de Acción

3.3.1 Promoción de comportamientos saludables

Esta línea de acción busca desarrollar y fortalecer conocimientos, actitudes, valores, habilidades y competencias de los alumnos, necesarios para mejorar y conservar su propia salud, la de su familia y comunidad. Asimismo permite desarrollar y fortalecer comportamientos para una vida sana, plantea experiencias de aprendizaje intencionadas, valiéndose de procesos pedagógicos participativos y significativos, en todas las oportunidades educativas y recreativas del plan curricular y en las actividades con los padres de familia y la comunidad.

Para lograr desarrollar esta línea de acción el Programa propone una intervención en el aula a partir del trabajo de ejes temáticos priorizados: higiene y ambiente, alimentación y nutrición, actividad física, salud sexual y reproductiva, habilidades para la vida, seguridad

vial y cultura de tránsito, promoción de la salud mental. buen trato y cultura de paz .

Se trabaja esta línea de acción a través de capacitaciones realizadas por las Direcciones Regionales de Salud a los profesionales de la Salud los cuales harán una réplica con los docentes, siendo ellos quienes posteriormente desarrollen sesiones con los estudiantes y padres de familia.

Los ejes temáticos se desarrollarán con los siguientes materiales:

Educación Primaria: Guías pedagógicas para el profesional de salud por cada eje temático, Guías pedagógicas para el docente por cada eje temático y Cuadernos de trabajo, módulos, láminas educativas y folletos para el estudiante.

Educación Secundaria: Guías pedagógicas para el profesional de salud por cada eje temático, Guías pedagógicas para el docente por cada eje temático, Cuadernos de trabajo, módulos, láminas educativas y folletos para el estudiante. Los materiales son diseñados teniendo en cuenta la realidad local, para ello se sugiere la adaptación de los materiales según cada realidad.

3.3.2 Desarrollo de entorno saludable

Cuando hablamos de entorno, hacemos referencia a la estructura física de la escuela y a las relaciones interpersonales y de comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa. Este ambiente favorecerá o restará viabilidad y eficacia a la labor formativa de la institución educativa, en tanto establece las condiciones básicas para el desarrollo de las actividades pedagógicas y las posibilidades de aprendizaje de los alumnos.

Para que un ambiente sea favorable a la salud y sea propicio para el aprendizaje, es necesario que la institución educativa cuente con instalaciones en buenas condiciones, aulas espaciosas, áreas de recreación, instalaciones sanitarias completas y en funcionamiento, etc. También es necesario que se promuevan relaciones interpersonales constructivas, armónicas y respetuosas entre estudiantes, profesores, padres de familia y directivos, creando un ambiente psicosocial agradable para aprender.

Para trabajar esta línea, el Programa contempla la elaboración y ejecución de un plan de actividades de mejoramiento físico por parte de la institución educativa en los temas de: agua segura, creación de kioskos saludables, además de un plan de desarrollo de habilidades para la vida como comunicación asertiva, relaciones interpersonales, manejo de conflictos, manejo de estrés, dirigido a los profesores y padres de familia.

En esta línea de acción se contempla la implementación de botiquines de aula con la asesoría y capacitación del Centro de Salud.

3.3.3 Trabajo intersectorial

El espacio escolar es uno de los más propicios para la labor de promoción de la salud, por ello es imprescindible crear nexos entre la comunidad educativa y los servicios de salud de la comunidad, en tanto ambos son instituciones líderes de desarrollo.

Para lograr el trabajo articulado y organizado, el personal de salud coordinará con el Consejo Educativo Institucional de cada institución educativa con quienes programará ejecutará y evaluará las actividades de promoción de la salud.

El Consejo Educativo Institucional está conformado por los siguientes miembros: director, sub director, representante de profesores, representante de estudiantes, representante de padres de familia, y además puede participar el responsable de promoción de la salud del centro de salud de su jurisdicción, brindando asistencia técnica.

3.3.4 Implementación de políticas que promuevan salud

Esta línea de acción difunde el conocimiento de las principales necesidades que afectan la salud de la comunidad educativa y apoya la adopción de medidas que favorecen la salud y la vida.

Las políticas saludables en el ámbito escolar deben ser una manifestación explícita y objetiva de la voluntad y el compromiso de la comunidad educativa con el mejoramiento de las condiciones de salud y de aprendizaje. Debe focalizar las acciones en las necesidades que la comunidad educativa considere prioritarios.

A continuación algunos ejemplos de políticas que promueven salud en el ámbito escolar: ambientes escolares libres de tabaco, normas para vivir una cultura de paz y buen trato, pautas que estimulan el ejercicio físico, pautas que estimulan los hábitos alimentarios saludables, entre otras.

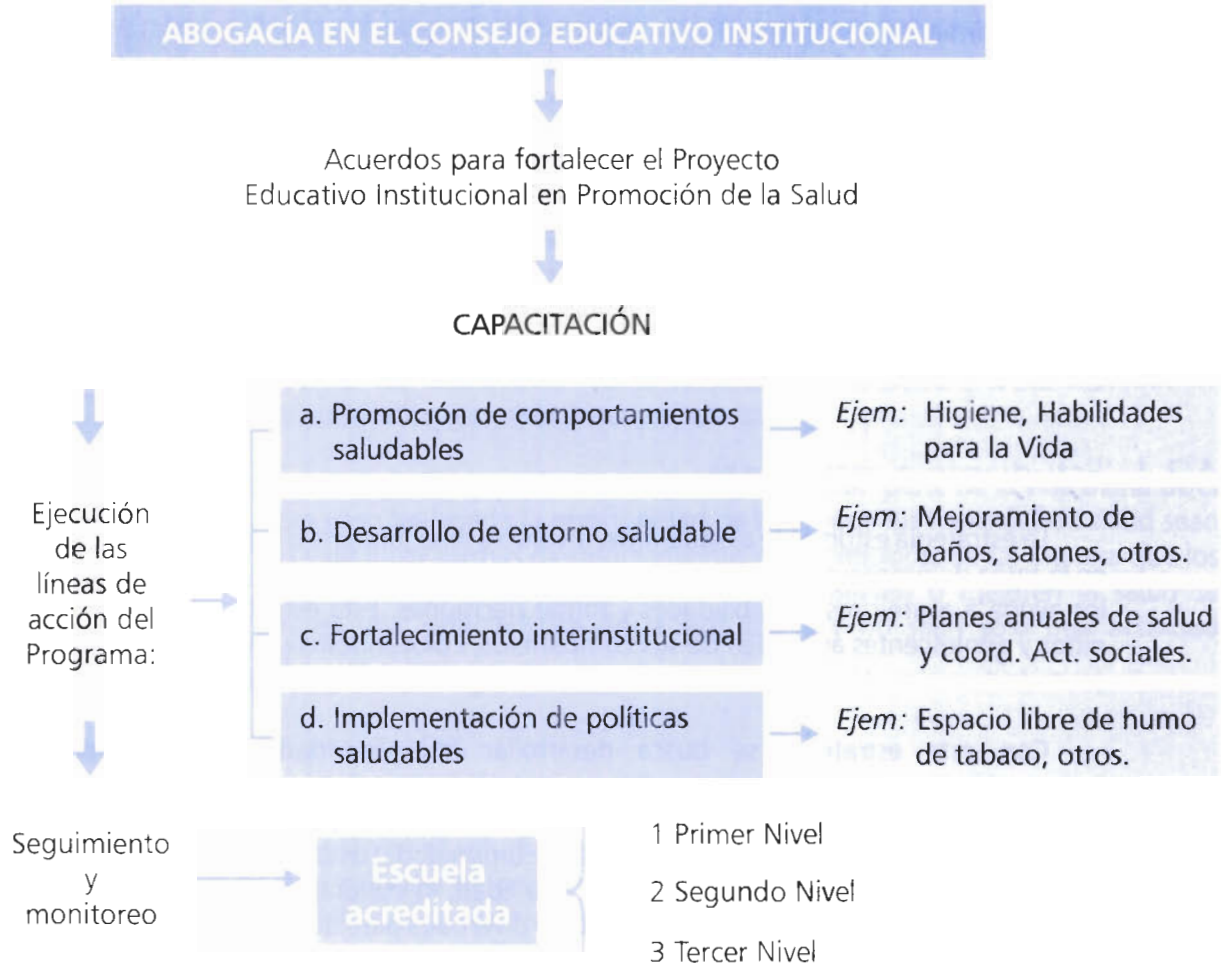
Las políticas saludables ayudan además a focalizar las acciones y los recursos en aquellas necesidades o aspectos identificados como prioritarios y de interés de la comunidad educativa.

CAPÍTULO 4

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN

Grafico N. 01

Proceso para Intervención del Programa de Promoción de Salud en las Instituciones Educativas



En el gráfico N° 01 se explica la metodología de implementación del Programa de Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas, que consta de los siguientes pasos:

1. **Abogacía en el Consejo Educativo Institucional**
   Se informa sobre la normatividad vigente, se sensibiliza a los actores involucrados para conseguir la suscripción del acta de compromiso en la cual la institución educativa asume la responsabilidad junto con el establecimiento de salud de implementar el Programa.

2. **Acuerdos para fortalecer el Proyecto Educativo Institucional en Promoción de la Salud**
   Luego de la sensibilización la institución educativa desde el Consejo Educativo Institucional y el Establecimiento de Salud se responsabilizan para la implementación del Programa, incorporando las acciones de Promoción de la Salud en el Proyecto Educativo Institucional y el Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa.

3. Capacitación
   El establecimiento de salud se encarga de brindar asesoría técnica y capacitación a los docentes de la institución educativa a su cargo. Proporciona materiales educativos en salud para el desarrollo de los ejes temáticos planteados en el Programa.

4. Ejecución de líneas de acción
   Se desarrollan las 4 líneas de acción mencionadas en el Programa.

5. Seguimiento y Monitoreo
   El establecimiento de salud hace visitas de seguimiento, asesoría y monitoreo a la ejecución del Programa en la institución educativa a su cargo.

6. Acreditación
   Al final del año se realiza una evaluación con el objetivo de verificar el logro del cumplimiento de los estándares de acreditación planteados en el Programa.

4.2 Metodologías Educativas para Fortalecer la Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas

4.2.1 Estudiante a estudiante

La estrategia estudiante a estudiante, involucra directamente a los niños y adolescentes en la tarea de promover salud. Los niños y adolescentes aprenden y ganan confianza; esto los ayuda a asumir responsabilidades y tomar decisiones. Esta estrategia plantea que los niños y adolescentes aprenden de sus compañeros, colocándolos como modelos válidos y asumiéndose simultáneamente ellos mismos como personas capaces de enseñar.

Con esta estrategia se busca desarrollar la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad, para con sus compañeros en relación a temas que ellos consideran buenos e importantes. Se trata de involucrarlos en la promoción de la salud reconociendo la importancia de su rol dentro de sus familias y comunidad. Los mensajes que comunicarán los niños y adolescentes serán adecuados a la edad, la cultura, las prioridades de salud. Deben ser mensajes pertinentes, interesantes y divertidos para que los niños y adolescentes se involucren con lo aprendido.

Los niños y adolescentes pueden ayudar a sus compañeros: dando buen ejemplo e influyendo en el comportamiento de sus compañeros, contándoles a sus padres lo que han aprendido en la institución educativa, elaborando afiches, componiendo canciones, creando juegos en grupo, comunicando mensajes a los adultos formando parte en campañas de salud y otras actividades de la comunidad.

La estrategia estudiante a estudiante tiene un efecto importante sobre la manera como se enseña, pues el estudiante relaciona con lo que hace en su vida diaria, promoviendo una educación vivencial, relaciona también lo que hacen en el aula con lo que sucede en la familia y la comunidad, lo que fortalece de manera significativa la experiencia pedagógica, pues se inserta en su vida cotidiana.

Las actividades se desarrollan, se aprenden y vivencian a lo largo de un período prolongado de tiempo. El desarrollo de la estrategia se basa en un trabajo en aula por proyectos que involucran los dos principales entornos de desarrollo del alumno, la institución educativa y la familia.

- En el aula se escoge y desarrolla un tema de salud, es preferible motivar a los niños y adolescentes a que sean ellos mismos quienes escojan el tema, propiciando un ambiente de confianza y seguridad para la discusión y reflexión, donde los niños y adolescentes puedan expresarse, en casa obtener más información sobre un tema en particular. Este paso debe brindarles la oportunidad de identificar la relación entre la situación específica de sus familias y comunidades y lo que han aprendido.

- De acuerdo a la edad del grupo se enseñará a recoger la información; en el aula, discutir los resultados y elaborar planes de acción, para lo cual presentan y analizan la información recopilada y la usan para programar lo que pueden hacer acerca de los problemas identificados a través de los datos recopilados. La presentación de la información se puede hacer de diversas formas como sociodramas, afiches, canciones, etc.

- Se debe motivar a los estudiantes para que actúen en sus familias y comunidades, poniendo en práctica lo aprendido en la institución educativa.

- En el aula se deberá discutir los resultados de las acciones realizadas. Las actividades de evaluación son importantes para verificar si los conocimientos sobre salud son significativos, si los estudiantes realmente están participando y si los métodos de enseñanza empleados son pertinentes y efectivos.

- En casa se debe ayudar a que los mensajes de salud sean parte de la vida diaria de la familia. Este paso les brinda la oportunidad de hacer que los mensajes de salud sean más claros y de idear formas de reforzamiento de los mismos, de tal manera que los cambios deseables en el comportamiento que conserven o mejoren la salud se conviertan en una característica de la vida diaria y no sean sólo una actividad transitoria.

4.2.2. Método de proyectos

Este método basa su propuesta en la utilización de experiencias concretas de la vida cotidiana para lograr en el estudiante aprendizajes y respuestas activas por medio de proyectos para la solución de problemas. Este método, resulta de la pedagogía activa, donde se parte del principio que el estudiante es el centro de la actividad en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje.

Esta propuesta metodológica postula que el recorrido del proceso de aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto, es decir la construcción del conocimiento parte de la experiencia. Se parte de lo que se sabe, de lo que es familiar, para educar. Todo se construye sobre la experiencia. El medio familiar y social es utilizado al máximo.

El proceso de aprendizaje se produce en las técnicas de investigación, el estudiante efectúa tomas de conciencia diferente a las verbales, lo que hace que se produzca un efecto positivo sobre la transferencia de conocimientos.

Para garantizar la eficiencia, se deben tomar en cuenta los procesos y recursos siguientes: la planificación del proyecto, la implementación del curso, el material didáctico necesario y el procedimiento.

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la relación estudiante y profesor, recordando siempre que el estudiante constituye el centro del proceso y que el rol del profesor es de facilitador y asesor.

Además, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Método no directivo
- Motivación
- Trabajo en equipo
- Integración de materias
- Retroalimentación
- Interacción

En la primera fase, el profesor conduce al estudiante a hacerse una o varias ideas acerca de un problema o tema a tratar. En la segunda fase el profesor debe asegurarse de que los estudiantes posean las herramientas necesarias para desarrollar su proyecto y verificar igualmente su capacidad de solución de problemas. En la tercera, el estudiante debe poseer las facultades que le permitan analizar e interrelacionar los datos a lo largo del proceso educativo. En la cuarta, el estudiante construye alternativas de solución al problema u obstáculo, incorporándolas a la organización de su propia estructura cognitiva. Por último el estudiante selecciona la o las alternativas pertinentes para la óptima resolución del problema planteado y trabajado.

El método de proyectos supone que el énfasis es puesto antes que todo, sobre el estudiante como responsable de su aprendizaje. Algunos trabajos son sugeridos a los estudiantes, quienes encontrarán allí actividades durante algunas semanas.

El profesor permanece aquí como el orientador que guía las posibilidades personales de los alumnos, al mismo tiempo que es el animador y consejero de la elaboración del proyecto.

4.3 Acreditación de Instituciones Educativas

El establecimiento de salud es el responsable de realizar la acreditación a las instituciones educativas.

4.3.1 Lógica de acreditación

La acreditación de las instituciones educativas tendrá tres niveles de logro progresivos en la aplicación y adaptación del programa. Esta lógica se sustenta en la intervención pedagógica que comienza en el aula y se expande hacia toda la institución educativa y su entorno.

4.3.2 Niveles de acreditación de la institución educati

Primer nivel.- La institución educativa comprende la importancia de unir esfuerzos entre los dos sectores de Educación y Salud para conservar y mejorar la salud de la comunidad educativa. La institución educativa y el centro de salud firman un acta por medio del cual se comprometen a realizar acciones de promoción de la salud por medio del Programa de Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas. Para el primer nivel se iniciará con la intervención de los ejes temáticos de higiene y ambiente y habilidades para la vida. (Anexo N° 01).

Segundo Nivel.- Los miembros de la comunidad educativa realizan actividades para desarrollar las cuatro líneas de acción del Programa. Se trabaja los ejes temáticos de higiene y ambiente, alimentación y nutrición, salud sexual reproductiva y habilidades para la vida. (Anexo N° 02).

Tercer nivel.- Se trabaja los ejes temáticos de higiene y ambiente, alimentación y nutrición, actividad física, salud sexual reproductiva, habilidades para la vida, seguridad vial y cultura de tránsito, promoción de la salud mental, buen trato y cultura de paz. Además de los ejes temáticos se trabaja todas las líneas de acción del Programa y la promoción de la salud es incorporada al Proyecto Educativo Institucional de la institución educativa. (Anexo N° 03).

Monitoreo y Evaluación

El monitoreo y evaluación del Programa se encuentran detallados en la Directiva N° 045-MINSA/DGPS-V.01 denominada "Indicador de Implementación del Programa de Promoción de la Salud en los Centros Educativos 2004", aprobada por Resolución Ministerial N° 1032-2004-MINSA, y en la Directiva N° 056-MINSA/DGPS-V.01 "Implementación del Programa de Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas en el año 2005".

ANEXOS

NIVELES DE ACREDITACION

Anexo

Primer Nivel de Acreditación de las Instituciones Educativas

LINEAS DE ACCIÓN	INDICADORES	FUENTE DE VERIFICACIÓN
PROMOCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SALUDABLES	Desarrollo de los ejes temáticos de higiene y ambiente y habilidades para la vida.	Informe del responsable de Promoción de la Salud del centro de salud sobre el desarrollo de los ejes temáticos. Informe de monitoreo de la visita al aula de clase (1 por mes).
DESARROLLO DE ENTORNO SALUDABLE	Elaboración y ejecución de un plan de actividades en la institución educativa que fomente: - Servicios Higiénicos limpios y funcionando. - Tachos en aulas y patios. - Aulas limpias. - Tanques con agua tapados.	Informe de visita a la institución educativa por el responsable de Promoción de la Salud del centro de salud.
TRABAJO INTERSECTORIAL	Abogacía en el Consejo Educativo Institucional. Participación del personal de salud en el Consejo Educativo Institucional de la institución educativa brindando apoyo técnico para la programación, ejecución y evaluación de las actividades de promoción de la salud. Aplicación de encuesta a alumnos para el diagnóstico basal.	Informe de reuniones, libro de acta. Copia del proyecto educativo institucional correspondiente a las acciones de promoción de la salud. Consolidado de encuestas.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN SALUD	Ninguno.	Ninguno.

LÍNEAS DE ACCIÓN	INDICADORES	FUENTE DE VERIFICACIÓN
PROMOCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SALUDABLES	Desarrollo de los ejes temáticos de higiene y ambiente, alimentación y nutrición, salud sexual y reproductiva y habilidades para la vida.	Informe del responsable de Promoción de la Salud del centro de salud sobre el desarrollo de los temas de salud. Informe de monitoreo de la visita al aula de clase (1 por mes).
DESARROLLO DE ENTORNO SALUDABLE	Elaboración y ejecución de un plan de actividades en la institución educativa que fomente: - Servicios higiénicos limpios y funcionando - Tachos en aulas, patios y otros ambientes. - Tanques con agua tapados. - Tienen agua segura. - Rincones de aseo en todas las aulas. - Aulas y patios limpios. - Implementación de bio-huerto y/o áreas verdes. - Implementación del botiquín escolar. Desarrollo del eje temático de habilidades para la vida en docentes, y padres de familia.	Informe de visita a la institución educativa por el responsable de Promoción de la Salud del centro de salud. Informe de talleres de habilidades para la vida.
TRABAJO INTERSECTORIAL	Plan de actividades coordinadas con el Consejo Educativo Institucional. Capacitación de promotores escolares por el centro de salud	Copia del plan. Consolidado de los resultados post capacitación. Informe de visita a la escuela.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN SALUD	Implementación de un política que promueva salud en las Instituciones Educativas.	Resolución Directoral.

Tercer Nivel de Acreditación de las Instituciones Educativas

LÍNEAS DE ACCIÓN	INDICADORES	FUENTE DE VERIFICACIÓN
PROMOCIÓN DE COMPORTA-MIENTOS SALUDABLES	Desarrollo de los ejes temáticos de higiene y ambiente, alimentación y nutrición, actividad física, salud sexual y reproductiva, habilidades para la vida, seguridad vial y cultura de tránsito y promoción de la salud mental, buen trato y cultura de paz para el nivel primario y secundario.	Informe del responsable de Promoción de la Salud del centro de salud sobre el desarrollo de los temas de salud.
	Incorporación de la promoción de la salud en el Proyecto Educativo Institucional.	Copia del Proyecto Educativo Institucional.
DESARROLLO DE ENTORNO SALUDABLE	Elaboración y ejecución de plan de actividades en el Centro Educativo que fomente: - Servicios higiénicos diferenciados, limpios y funcionando. - Aulas con mobiliario e iluminación adecuada. - Tachos en aulas, patios y otros ambientes. - Actividades de reciclaje de basura. - Tanques con agua tapados. - Rincones de aseo en todas las aulas. - Aulas y patios limpios. - Implementación de bio-huerto y/o áreas verdes. - Campos deportivos y/o área de juego para niños. - Mantenimiento de fachada y aulas del centro educativo.	Informe de visita a la institución educativa por el responsable de Promoción de la Salud del centro de salud.
	Cuentan con un plan de capacitación anual para padres de familia, docentes y administrativos en el tema de habilidades para la vida.	Copia del Plan de Capacitación.
	Desarrollo de pautas de crianza para padres de familia.	Informe de resultados de capacitación
TRABAJO INTERSECTORIAL	Plan de actividades coordinadas con el centro de salud. Capacitación de promotores escolares realizado por profesional de salud. Implementación del botiquín escolar. Actividades coordinadas con el Consejo EducativoInstitucional y Gobiernos locales.	Copia del plan de actividades Lista de alumnos promotores de la salud. Informe de visita a la institución educativa. Copia del plan de actividades.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN SALUD	Implementación de dos políticas públicas.	Resolución Directoral.

BIBLIOGRAFÍA

Lineamientos de Política Sectorial para el Período 2002-2012 y Principios Fundamentales para el Plan Estratégico Sectorial del quinquenio Agosto 2001-Julio 2006. Ministerio de Salud

Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2020 Junio 2002-ministerio de Promoción de La Mujer y del Desarrollo Humano.

Lineamientos de Política Educativa 2001-2002: Educación para la Democracia. Lima, Diario El Comercio, Domingo 13 de Enero 2002.

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000. Instituto Nacional de Estadística e Informática y otros. Lima, Mayo del 2001.

La Exclusión Social en el Perú. UNICEF. Lima, Junio del 2001.

Educación en habilidades para la vida en Escuelas Saludables del Departamento de Santander. Secretaría de Salud de Santander-Fe y Alegría Regional Santander, Bucaramanga 2002.

Hacia la construcción de Escuelas Saludables-Guía para Docentes y Personal de Salud. Instituto de Programas Interdisciplinarios en Atención Primaria de la Salud de la Universidad Industrial de Santander-PROINAPSA-UIS, Marzo 2000.

Cuaderno de Promoción de la Salud No 1-Red de Escuelas Promotoras de la Salud del Perú-Comisión Multisectorial de Escuelas Promotoras de Salud.-Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y OPS.